Cabinet de dermatologie Es-Senia

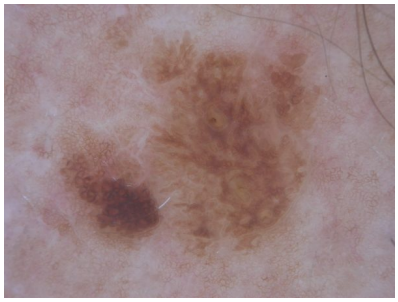
تقرير المساعدة على الفرز — آفة جلدية

dermIA الإصدار 2.0.0 · النموذج ham10000-m5-v2 الإصدار 2.0.0 (الملف: كامل)

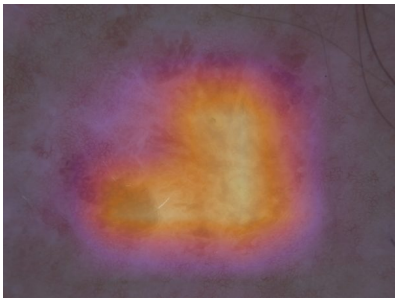
المريض	P-2026-0423	تاريخ التحليل	22:38 21/05/2026
العمر (بالسنوات)	70	طلب التحليل	Dr Karim Haddad
الجنس	ذكر	الموضع	الظهر
الآفة المتابعة	رقم 1 — dos, sous l'omoplate gauche	عتبات القرار	الأصلية

حميد على الأرجح

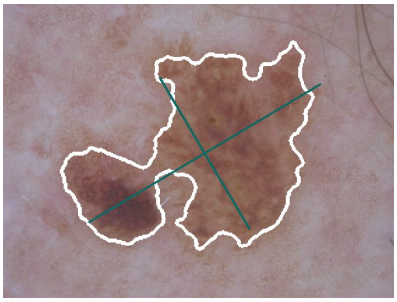
تقرن حميد مرجح
آفة حميدة على الأرجح. المتابعة حسب التقدير السريري، وأي تغير في الآفة يستدعي فحصا جديدا.



الصورة المحللة



المناطق الأكثر تأثيرا (Grad-CAM، «تقرن حميد»)



الحدود والمحاور المستخدمة في معايير ABCD

الاحتمالات المقدرة

التشخيص	الاحتمال	ضمن المجموعة المضمونة*
تقرن حميد	94,1%	نعم
ورم ميلانيني	4,1%	
وحمة ميلانينية	1,8%	
تقرن سفعي / داء بوين	0,0%	
ورم ليفي جلدي	0,0%	
سرطانة الخلايا القاعدية	0,0%	
آفة وعائية	0,0%	

* المجموعة المطابقة (طريقة موندريان، ألفا = 0,10): تحتوي على التشخيص الصحيح باحتمال لا يقل عن 90% لكل فئة، بافتراض أن الحالات تشبه بيانات المعايرة. يتخذ قرار الورم الميلانيني إذا كان p(mel) ≥ 0,10 (نسبة التكلفة R = 10).
عتبات النموذج الأصلية، معايرة على مجموعة المعايرة من HAM10000.

معايير ABCD الآلية (استرشادية)

المعيار	القياس	التفاصيل
A — عدم التناظر	2/2	محاور رئيسية غير متناظرة (الشكل أو الألوان)
B — الحواف	1/8	قطاعات ذات حافة حادة
C — الألوان	2/6	بني داكن، أزرق رمادي
D — القطر	10,7 مم	أكثر من 6 مم

قياسات آلية استرشادية: على مجموعة الاختبار من HAM10000 لا يميز كل منها بين الورم الميلانيني والوحمة إلا بشكل محدود (AUC من 0,66 إلى 0,73). وهي لا تغني عن الفحص بالمنظار الجلدي.

المراجعة الطبية

أكدها Dr Karim Haddad بتاريخ 22/05/2026.
التشخيص المعتمد: تقرن حميد

توقيع الطبيب: _____

تنبيه. أعدت هذه الوثيقة بواسطة أداة للمساعدة على اتخاذ القرار، وهي لا تعد تشخيصا ولا تغني عن الفحص السريري ولا عن الفحص النسيجي. حالة النموذج: عرض توضيحي — استخدام غير تجاري — ليس جهازا طبيا. بيانات التدريب: HAM10000 (Tschandl et al., Sci Data 2018, doi:10.1038/sdata.2018.161) — الترخيص CC BY-NC 4.0 (غير تجاري).